

CAPÍTULO 1.1

Manejo de Urgencias en Arritmias

PERFIL EUNACOM 1.01.2.009

Dx: Específico • Tx: Inicial • Seg: Derivar

El manejo de las arritmias en el servicio de urgencias es un pilar fundamental de la medicina de emergencia. Ante un paciente con una alteración del ritmo cardíaco, la prioridad inicial no es el diagnóstico electrocardiográfico preciso de la arritmia, sino la evaluación del estado hemodinámico del paciente.

Clasificación Clínica del Paciente

En la urgencia, un paciente con arritmia puede presentarse de tres formas principales, lo que determinará la agresividad y el tipo de intervención:

- **Paro Cardiorrespiratorio (PCR):** El paciente no tiene pulso ni ventilación espontánea.
- **Hemodinámicamente Inestable:** El paciente presenta signos de hipoperfusión o falla orgánica secundaria a la arritmia.
- **Hemodinámicamente Estable:** El paciente mantiene una perfusión adecuada, lo que permite un estudio más pausado.

NOTA CLÍNICA

La inestabilidad hemodinámica en el contexto de una arritmia se define generalmente por la presencia de al menos uno de los siguientes criterios (frecuentemente llamados "los 4 jinetes del apocalipsis" de la arritmia): - **Hipotensión arterial** (shock). - **Alteración aguda del estado mental** (compromiso de conciencia). - **Dolor torácico isquémico** (angina). - **Insuficiencia cardíaca aguda** (edema agudo de pulmón).

1. Manejo del Paciente en Paro Cardiorrespiratorio

Si el paciente llega en PCR, se debe activar de inmediato el protocolo de **RCP Avanzado (Resucitación cardiorrespiratoria)**. La prioridad es diferenciar entre ritmos desfibrilables y no desfibrilables:

- **Ritmos Desfibrilables:** Fibrilación Ventricular (FV) y Taquicardia Ventricular sin pulso (TVSP). El tratamiento clave es la **desfibrilación** temprana.
- **Ritmos No Desfibrilables:** Asistolia y Actividad Eléctrica Sin Pulso (AESP). El tratamiento se basa en compresiones de alta calidad y administración de adrenalina.

2. Manejo de las Taquiarritmias Inestables

Cuando un paciente presenta una frecuencia cardíaca elevada (generalmente >150 lpm) y signos de inestabilidad hemodinámica, el tratamiento es único e independiente del diagnóstico específico en el EKG.

- **Medida de elección: Cardioversión Eléctrica (CVE) Sincronizada** de inmediato.
- **Concepto clave:** No se debe perder tiempo intentando fármacos o realizando un EKG de 12 derivaciones completo si el paciente está chocado. La prioridad es restablecer el gasto cardíaco mediante electricidad.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Es vital que la cardioversión sea **sincronizada** (el monitor detecta la onda R) para evitar el fenómeno de "R sobre T", el cual puede gatillar una Fibrilación Ventricular. Solo se usa desfibrilación (no sincronizada) si el paciente no tiene pulso.

3. Manejo de las Bradiarritmias Inestables

Si el paciente presenta una frecuencia cardíaca baja (generalmente <50 lpm) con compromiso hemodinámico (frecuente en **Bloqueos aurículo-ventriculares** de alto grado), el manejo sigue una escala de agresividad:

- **Atropina:** Es la primera medida farmacológica (dosis de 1 mg IV, pudiendo repetirse hasta 3 mg).

- **Drogas Vasoactivas:** Si la atropina falla, se pueden utilizar infusiones de **Adrenalina** o Dopamina.
- **Marcapaso Externo Transitorio (Cutáneo):** Debe instalarse de inmediato si el paciente no responde a la atropina o si hay un retraso previsto en el inicio de las drogas. Es una medida puente hasta el marcapaso definitivo.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, recuerda: "**Taqui-Inestable = Electricidad (CVE)**" y "**Bradi-Inestable = Atropina / Marcapaso**". Nunca elijas fármacos antiarrítmicos (como amiodarona) para una taquicardia que tiene hipotensión o dolor torácico; la respuesta correcta siempre será cardioversión eléctrica.

4. Manejo del Paciente Hemodinámicamente Estable

Si el paciente está estable, tenemos el "lujo" de realizar un análisis detallado. Aquí es donde el algoritmo se bifurca según los hallazgos del EKG de 12 derivaciones:

- **Paso 1:** Evaluar si el complejo QRS es ancho (>0.12s) o estrecho (<0.12s).
- **Paso 2:** Evaluar si el ritmo es regular o irregular.
- **Paso 3:** Iniciar manejo farmacológico específico o maniobras vagales según corresponda.

TABLA 1.1.1: TIPO DE ARRITMIA ESTABLE VS EJEMPLO COMÚN

TIPO DE ARRITMIA ESTABLE	EJEMPLO COMÚN	MANEJO INICIAL SUGERIDO
QRS estrecho regular	Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)	Maniobras vagales / Adenosina
QRS estrecho irregular	Fibrilación auricular crónica	Control de frecuencia (Betabloqueo / Calcioantagonistas)
QRS ancho regular	Taquicardia Ventricular monomórfica	Amiodarona / Procainamida
Bradicardia estable	Bloqueo AV de 1er grado	Observación / Estudio de causas reversibles

Resumen de Manejo según Hemodinamia

TABLA 1.1.2: ESTADO CLÍNICO VS ACCIÓN INMEDIATA

ESTADO CLÍNICO	ACCIÓN INMEDIATA
Paro Cardiorrespiratorio	RCP Avanzado + Desfibrilación (si aplica)
Taquicardia Inestable	Cardioversión Eléctrica Sincronizada
Bradicardia Inestable	Atropina → Marcapaso Transitorio
Paciente Estable	EKG 12 derivaciones → Diagnóstico específico → Fármacos

EUNACOM CRITERIOS

Ante cualquier arritmia con compromiso de conciencia o hipotensión, el **ABCDE** y la preparación para la intervención eléctrica deben ser simultáneos. La derivación a un centro con capacidad de cuidados intensivos y cardiología es obligatoria tras la estabilización inicial.

Insuficiencia cardíaca aguda Infarto agudo al miocardio Manejo del paciente en tratamiento anticoagulante

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

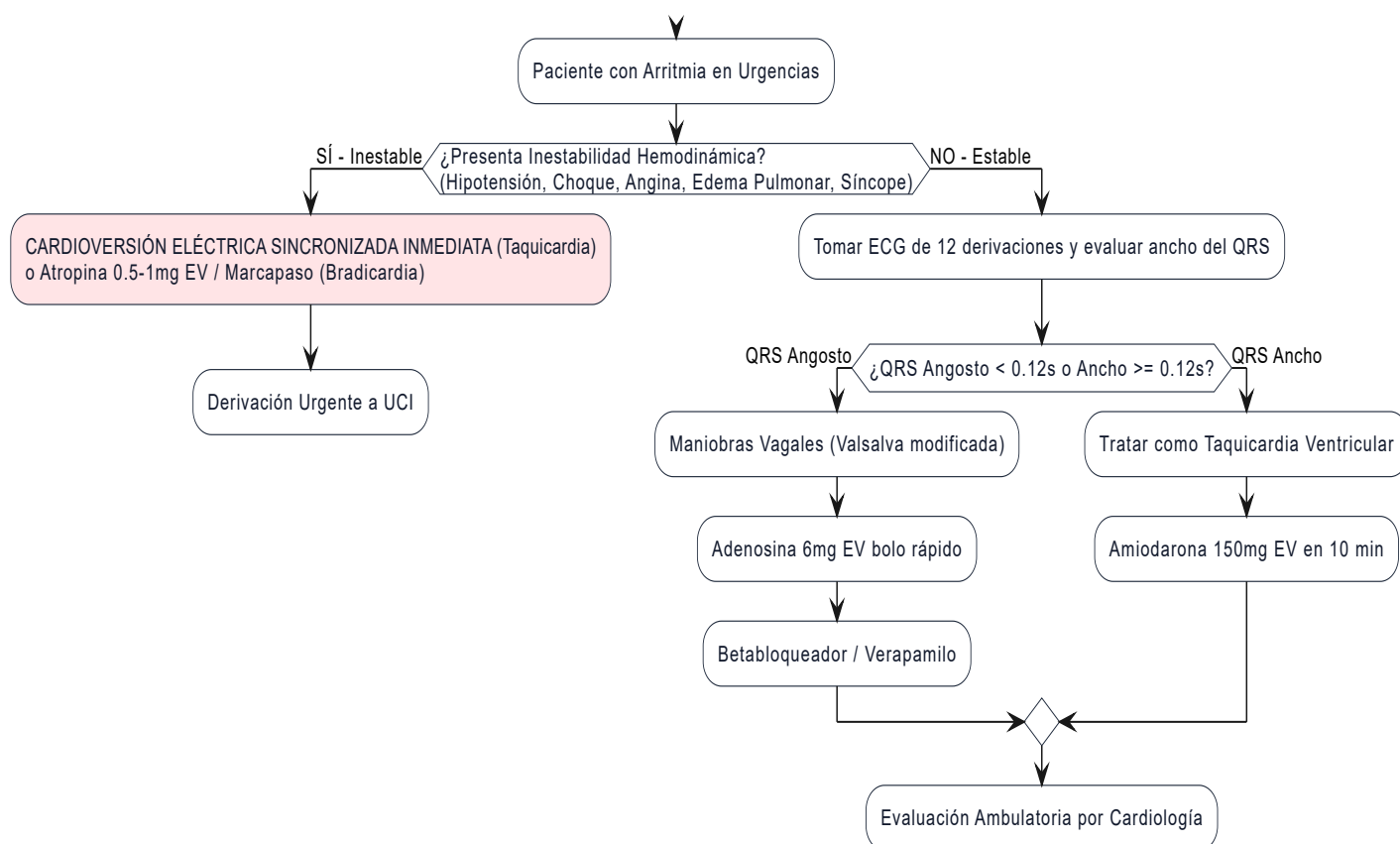
"Mujer de 60 años con estenosis mitral severa presenta palpitaciones y disnea aguda. Al examen: PA 85/40 mmHg, FC 150 lpm irregular, edema pulmonar agudo. ECG revela taquicardia de complejo QRS angosto irregular compatible con fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

En cualquier taquiarritmia o bradiarritmia en urgencias, la presencia de compromiso hemodinámico exige Cardioversión Eléctrica Sincronizada inmediata.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Clasificación del paciente en urgencia: paro cardiorrespiratorio, hemodinamia inestable o hemodinamia estable.
- Paro cardiorrespiratorio = RCP avanzado (ritmos desfibrilables vs no desfibrilables).
- Taquiarritmia con hemodinamia inestable = cardioversión eléctrica inmediata, independiente del tipo.
- Bradiarritmia con hemodinamia inestable = atropina o adrenalina, y si no responde, marcapasos externo transitorio.
- El bloqueo AV de tercer grado choqueado es el ejemplo clásico de bradiarritmia inestable.
- Solo con hemodinamia estable se lee el ECG de 12 derivaciones para identificar la arritmia específica.
- El manejo específico según tipo de arritmia solo aplica cuando hay estabilidad hemodinámica.

FIGURA 1.1B: ALGORITMO DE MANEJO DE URGENCIAS EN ARRITMIAS

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MANEJO DE URGENCIAS EN ARRITMIAS)**PREGUNTA 1**

Paciente de 65 años llega a urgencias con palpitaciones, presión arterial de 70/40 mmHg, palidez y sudoración fría. El monitor muestra una taquicardia de complejo ancho a 180 lpm. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?

- A)** Administrar amiodarona 300 mg en bolo endovenoso
- B)** Realizar cardioversión eléctrica sincronizada inmediata
- C)** Solicitar electrocardiograma de 12 derivaciones para identificar la arritmia
- D)** Administrar adenosina 6 mg en bolo endovenoso
- E)** Iniciar maniobras vagales y observar respuesta

PREGUNTA 2

Paciente de 78 años con antecedentes de hipertensión arterial llega a urgencias bradicárdico con frecuencia cardíaca de 32 lpm, presión arterial de 60/30 mmHg y compromiso de conciencia. Se administra atropina sin respuesta. ¿Cuál es el paso siguiente?

- A)** Repetir atropina en dosis más alta
- B)** Instalar marcapasos externo transitorio de inmediato
- C)** Administrar amiodarona endovenosa
- D)** Realizar cardioversión eléctrica sincronizada
- E)** Solicitar ecocardiograma urgente antes de decidir conducta

PREGUNTA 3

Paciente de 55 años consulta por palpitaciones de inicio hace 2 horas. Está vigil, orientado, presión arterial 130/80 mmHg, frecuencia cardíaca irregular de 140 lpm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Cardioversión eléctrica inmediata
- B)** Iniciar RCP avanzado
- C)** Realizar electrocardiograma de 12 derivaciones para identificar la arritmia
- D)** Administrar atropina 1 mg endovenoso
- E)** Desfibrilación inmediata a máxima energía

RESUMEN: MANEJO DE URGENCIAS EN ARRITMIAS

El manejo de urgencias en arritmias se estructura según la condición hemodinámica con la que llega el paciente: en paro cardiorrespiratorio, con hemodinamia inestable o con hemodinamia estable. Esta clasificación es fundamental porque determina completamente la conducta terapéutica inmediata. Cuando el paciente llega en paro cardiorrespiratorio, el manejo es el RCP avanzado, diferenciando entre ritmos desfibrilables y no desfibrilables. Si llega con hemodinamia inestable, la conducta depende del tipo de arritmia: las taquiarritmias hemodinámicamente inestables, independientemente de su tipo (fibrilación auricular, taquicardia ventricular o taquicardia supraventricular paroxística), se manejan siempre con cardioversión eléctrica inmediata. Las bradiarritmias con hemodinamia inestable se manejan con atropina o drogas vasoactivas como adrenalina, y si no responden rápidamente, con marcapasos externo transitorio. Finalmente, si el paciente llega con hemodinamia estable, recién en ese momento se procede a leer el electrocardiograma de 12 derivaciones para identificar exactamente qué arritmia tiene y manejarla según su tipo específico, lo cual se aborda en detalle en las clases siguientes.